

Prescripción centrada en la persona

Mikel Baza Bueno^{a,*}, Arritxu Etxeberria Agirre^b, Leire Gárate Sacristán^c, Ander López de Heredia Gutiérrez^d y Nekane Jaio Atela^e

^aMédico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de Zeberio. UAP Arrigorriaga. OSI Barrualde-Galdakao. Osakidetza. España.

^bFarmacéutica de Atención Primaria. OSI Donostialdea. Osakidetza. España.

^cMédica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UAP Sopela. OSI Uribe. Osakidetza. España.

^dMédico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de La Arboleda. UAP Trapaga. OSI Enkarterri-Ezkerraldea. Osakidetza. España.

^eFarmacéutica de Atención Primaria. OSI Barrualde-Galdakao. Osakidetza. España.

*Correo electrónico: mikelbaza@gmail.com

Puntos para una lectura rápida

- Nos encontramos en un contexto de aumento de la multimorbilidad y polimedicación, lo que supone un gran reto para los sistemas sanitarios, y pone de manifiesto la necesidad de una atención centrada en la persona.
- La prescripción centrada en la persona se basa en una evaluación multidimensional y multidisciplinar, incorporando las preferencias del paciente, que tiene como base cuatro principios: la atención centrada en la persona, la terapéutica prudente y razonada, el trabajo multidisciplinar y coordinado y la planificación compartida.
- La prudencia consiste en el manejo razonable de la incertidumbre, y es un requisito previo para un uso seguro de los medicamentos. Los principios de prescripción prudente deben aplicarse en cada una de las decisiones sobre tratamiento y en la revisión estructurada de la medicación (REM).
- La REM implica definir los objetivos terapéuticos globales de cada persona, identificar y priorizar los problemas de salud y evaluar los medicamentos en base a la necesidad, efectividad, adecuación y seguridad.
- La toma de decisiones compartida es un proceso de colaboración entre una persona y su profesional de la salud que implica tomar las decisiones basadas tanto en la evidencia, como en las preferencias, creencias y valores individuales de la persona.

Palabras clave: Polifarmacia • Multimorbilidad • Prescripción inadecuada • Atención centrada en la persona.

“A Antifonte (...) la experiencia le enseñó que conviene hacer hablar al que sufre los motivos de su pena, porque buscando las palabras a veces se escucha el remedio.”

El infinito en un Junco. Irene Vallejo

Introducción

Nos encontramos ante un contexto en el que cada vez hay más personas con multimorbilidad y polimedicación, lo que supone un gran reto tanto para el sistema sanitario, como para profesionales sanitarios y pacientes. Todo ello pone de manifiesto las limitaciones de un enfoque centrado única-

mente en la enfermedad, así como la necesidad de una atención centrada en la persona.

La multimorbilidad se define como la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una misma persona¹. En España, su prevalencia se encuentra en torno al 37,5% de la población general, de las cuales el 10,6% padece 5 o más enfermedades crónicas. El 80,3% de los mayores de 65 años presenta multimorbilidad, con una media de 4 enfermedades². Este fenómeno va de la mano de la polimedicación, definida como la toma de ≥ 5 medicamentos de forma continuada³ y de la hiperpolimedicación (≥ 10 medicamentos)⁴. La prescripción potencialmente inapropiada (PPI) es aquella cuyos potenciales riesgos pueden ser mayores que sus potenciales beneficios. La polimedicación y la PPI provocan peores resultados en salud, siendo el número de medicamentos que toma una persona el predictor más importante de la exis-

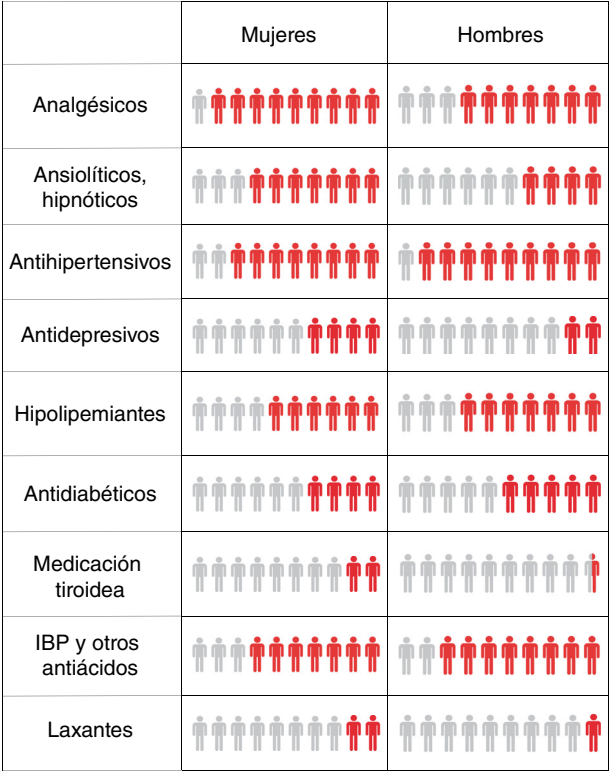


Figura 1. Fármacos más consumidos en personas > 65 años polimedradas en España. Distribución del uso de medicamentos en personas ≥65 años con polimedicación (n = 5.077) de una muestra de personas españolas no institucionalizadas ≥ 65 años (N = 21.841) que recoge datos secundarios de las entrevistas personalizadas de la Encuesta Nacional de Salud de España 2011/2012 y 2017, y de la EHIS (European Health Interview Survey) 2014 y EHIS 2020.Elaborada a partir de la referencia ¹⁴.

tencia de PPI y de efectos adversos⁵ (EA). Se estima que, por cada medicamento adicional, el riesgo de sufrir EA aumenta un 7-10%^{6,7}.

Además de los EA, en personas mayores, la polimedicación se ha asociado a peor adherencia al tratamiento, déficits cognitivos y funcionales, delirio, desnutrición y pérdida de peso, incontinencia, caídas y fracturas de cadera⁸. Se relaciona también con aumento de hospitalizaciones (11% atribuibles a fármacos; 70% prevenibles)⁹, ingreso en residencias, disminución de la calidad de la vida y de la calidad de la muerte, e incluso con un aumento de la mortalidad^{10,11}.

La prevalencia de la polimedicación es elevada y está aumentado de forma alarmante en todo el mundo¹². En España, según el estudio de la cohorte Epichron, entre 2005-2015 la prevalencia de la polimedicación se triplicó y la hiperpolimedicación se multiplicó por 10, siendo el mayor incremento en las personas mayores de 80 años^{6,13}. Existen diferencias entre sexos, tanto en la prevalencia de la polimedicación (mayor en mujeres)¹⁴ como en el perfil de fármacos más utilizados (fig. 1).

Una historia real

Detrás de todos estos datos se encuentran personas como Carmen (78 años). La salud le acompañó hasta que después del último embarazo le empezaron a “salir algunos asteriscos”: primero el azúcar, luego el colesterol, y más tarde la tensión, que a pesar de probar “casi todas las pastillas” siempre suele tenerla “un poco alta”. Al cabo de un tiempo comenzó con dolores lumbares, que acabaron llevándola al quirófano y a la unidad del dolor. En 2012 presentó un dolor en el pecho mientras trabajaba en la huerta, que resultó ser un infarto de miocardio y le colocaron un stent. Últimamente “se ahoga cuando sube alguna cuesta” por lo que toma inhaladores. En este tiempo Carmen ha ido sumando diferentes patologías y con ello también múltiples fármacos.

Carmen fue diagnosticada de varios problemas de salud en su tercera década de vida por lo que le prescribieron varios fármacos para la hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus tipo 2. Respecto a esta última, inicialmente, comenzó tomando metformina y una sulfunilurea, pero dado que no se alcanzaba el objetivo terapéutico deseado, el tratamiento fue cambiando y añadiendo otros fármacos. Desde hace 18 años está en tratamiento con insulina, lo que le supone realizar controles de glucemia capilar con mucha frecuencia. En la sexta década de vida, había tenido un infarto de miocardio y le aquejaba un dolor lumbar persistente, que aumentaron el número de fármacos de su tratamiento. Con 78 años Carmen toma más de 15 fármacos, incluyendo dispositivos de insulina e inhaladores.

En la historia natural del paciente con multimorbilidad, el enfoque terapéutico debe transitar, desde una prioridad preventiva y curativa hacia unos cuidados paliativos según se avanza en el tiempo. Es necesario determinar cuándo un paciente con multimorbilidad necesita otro tipo de cuidados aparte de sus tratamientos habituales, siendo recomendable que estos comiencen en las fases tempranas del diagnóstico de morbilidad avanzada que supone un pronóstico de vida limitado, y por tanto se incorporen progresivamente a medida que la enfermedad avanza, siendo compatibles con la aplicación de tratamientos curativos y preventivos (fig. 2).

¿Cómo afrontar la polimedicación y la prescripción inapropiada?

Los factores que favorecen la multimorbilidad y polimedicación son múltiples y complejos, y se explican solo parcialmente por el envejecimiento de la población. Los factores de tipo socioeconómico desempeñan un papel esencial, habiéndose puesto de manifiesto un adelanto de entre 10-15 años en la edad de aparición en personas de nivel socioeconómico

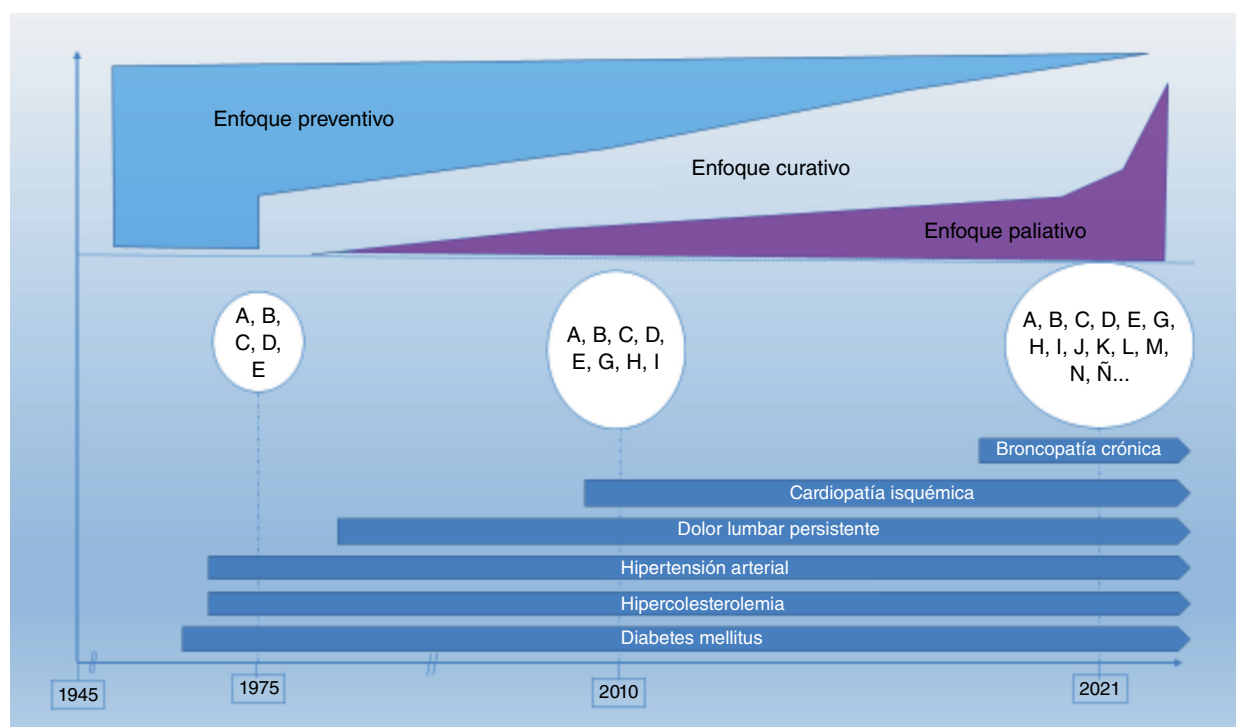


Figura 2. La historia de Carmen.

Elaborado a partir de una historia real. Fuente: Infac²⁹ y Muth et al.³².

bajo¹⁵. La aplicación de guías de práctica clínica (GPC) orientadas a la enfermedad y poco aplicables a personas frágiles y con comorbilidad¹ es otro de los factores fundamentales que lo explican.

Por otro lado, el conocimiento de las barreras y facilitadores que influyen en la gestión de la polimedición es clave para diseñar y aplicar estrategias dirigidas a la reducción de la polimedición, y mejorar la adecuación de la prescripción^{5,8,16,17}. Estos factores (tabla 1) están relacionados con la estructura y organización del sistema sanitario, la educación y cultura biomédicas de los profesionales sanitarios, las expectativas de los pacientes, o la medicalización de la vida, entre otros^{6,17}.

En las últimas décadas se han desarrollado múltiples intervenciones para mejorar la adecuación de la prescripción en persona mayores polimedizadas y con multimorbilidad, siendo las más frecuentes la revisión estructurada de la medicación (REM) (70%), seguidas de la formación (26,3%) y de las herramientas de apoyo (22,5%)¹⁸.

En general, las revisiones sistemáticas (RS) sobre intervenciones en polimedición han demostrado mejoras en la reducción del número de fármacos y de PPI. Su impacto sobre la morbilidad, la mortalidad y la utilización de los servicios sanitarios es más incierto¹⁹⁻²¹. Las intervenciones de deprescripción centradas en pacientes podrían ser más exitosas en variables clínicas que las generales como las intervenciones educativas⁵. Las REM realizadas en el medio hospitala-

rio pueden reducir los ingresos hospitalarios²², y la REM con integración de los farmacéuticos de atención primaria (FAP) muestra mejoras en la calidad de vida, reducción de hospitalizaciones y costes en algunos estudios^{23,24}. En la tabla 2 se muestran los elementos que hacen que las intervenciones de deprescripción y de REM funcionen, en atención primaria (AP) según una RS²⁵.

Carmen, además de frecuentar la AP, acude a varias consultas (cardiólogo, unidad del dolor, neumología, endocrinología) de donde provienen muchas de sus prescripciones. El resultado de la mayoría de estas consultas suele ser añadir o modificar algún fármaco, dejando poco margen a las alternativas no farmacológicas. Respecto a sus creencias y expectativas sobre algunos fármacos relata que “llevo muchos años tomándola y el dolor seguía ahí” (pregabalina) o “tampoco creas que duermo demasiado” (lorazepam), y “tanto pinchazo y cachivache es complicado” (insulinas e inhaladores).

Prescripción centrada en la persona: una propuesta para llevar a la práctica

La prescripción centrada en la persona (PCP), se ha propuesto como un modelo para mejorar la atención, espe-

TABLA 1. Barreras y facilitadores para la mejora de la polimedicación y la deprescripción		
Barreras		Facilitadores
Culturales	La cultura predominante del diagnóstico y la prescripción (“pill for every ill” o “un fármaco para cada problema de salud”) Fármacos como primera opción en condiciones frecuentes (insomnio, dolor de espalda, tristeza...) Falta de conciencia sobre consecuencias negativas de los polimedicación	Cultura de la prescripción prudente. Cultura de “menos es más” en personas de mayor edad o con fragilidad Disponibilidad de intervenciones no farmacológicas (p.ej. prescripción social)
Modelos y guías basados en la enfermedad	Guías de práctica clínica para cada enfermedad y su aplicación acrítica a personas de mayor edad/frágiles Guías de sociedades científicas con financiación de la industria farmacéutica	Mejorar guías y herramientas sobre multimorbilidad basadas en la evidencia Mejorar la formación y la educación de profesionales en manejo de la multimorbilidad, deprescripción y decisiones compartidas
Fragmentación de la asistencia	Falta de comunicación, colaboración y coordinación entre múltiples prescriptores de distintos niveles asistenciales Percepciones y prácticas discrepantes Reticencias para modificar prescripciones iniciadas por otros Dilución de responsabilidades	Conocimiento mutuo, colaboración Trabajo en equipo multidisciplinar: medicina de familia, enfermería, farmacia, profesionales de atención hospitalaria Tiempo para revisar (objetivos de pacientes síntomas, tratamientos...) Mejorar usabilidad de historia clínica compartida Responsabilidad en la coordinación de cuidados de pacientes complejos
Profesional sanitario/ prescriptor	Incertidumbre Temor a consecuencias negativas de deprescripción o conflictos con pacientes Inercia (mantener el <i>statu quo</i>) Falta de formación Falta de tiempo	Mejora de la información y formación Formación y capacitación en toma de decisiones compartidas Reconocimiento/ incentivación/tiempo
Personas y pacientes	Incertidumbre de pacientes (“el que sabe es el doctor”) Delegación Actitudes prevalentes hacia personas mayores, migrantes o con problemas de salud mental	Mayor concienciación Cuidado basado en las personas, incluyendo perspectiva del paciente Planes de cuidado adaptados a cada paciente
Falta de revisión de la medicación	Falta de tiempo Prórrogas automáticas y prorrogar sin revisar	Facilitar herramientas de revisión Tiempo para revisión y reconocimientos de trabajo Incorporar la revisión a la práctica clínica habitual Integración de farmacéuticos en los equipos de atención primaria
Fuente: citas 5,6, 8, 16-17.		

TABLA 2. Elementos de las intervenciones para que la deprescripción sea efectiva	
1. Profesionales sanitarios: roles, responsabilidades y relaciones	
- Incorporación de farmacéuticos en los equipos multidisciplinarios, implicación de médicos de familia y de otros profesionales sanitarios - Mejorar la continuidad de la información atención primaria-atención especializada u hospitalaria, e incorporar la deprescripción como parte de la práctica habitual de la prescripción	
2. Formación de profesionales en deprescripción y en decisiones compartidas	
3. Forma del proceso de revisión	
- Proceso multidisciplinar eficiente: herramientas de apoyo a la revisión, sistemas de identificación de pacientes a riesgo, coubicación del farmacéutico en equipos de AP, comunicación asincrónica electrónica - Comunicación con pacientes: presencial si es posible, adaptada a necesidades, aprovechando otras citas - Seguimiento y apoyo: seguimiento programado, ofrecer la deprescripción como “prueba de retirada” siempre reversible	
4. Participación y educación de pacientes y cuidadores	
- Educación en fármacos, motivos para la revisión y deprescripción - Involucrar a pacientes a riesgo/cuidadores, comenzar con un cambio simple que pueda producir mejora de síntomas (“quick win”)	
Fuente: Radcliffe et al. ²⁵ .	

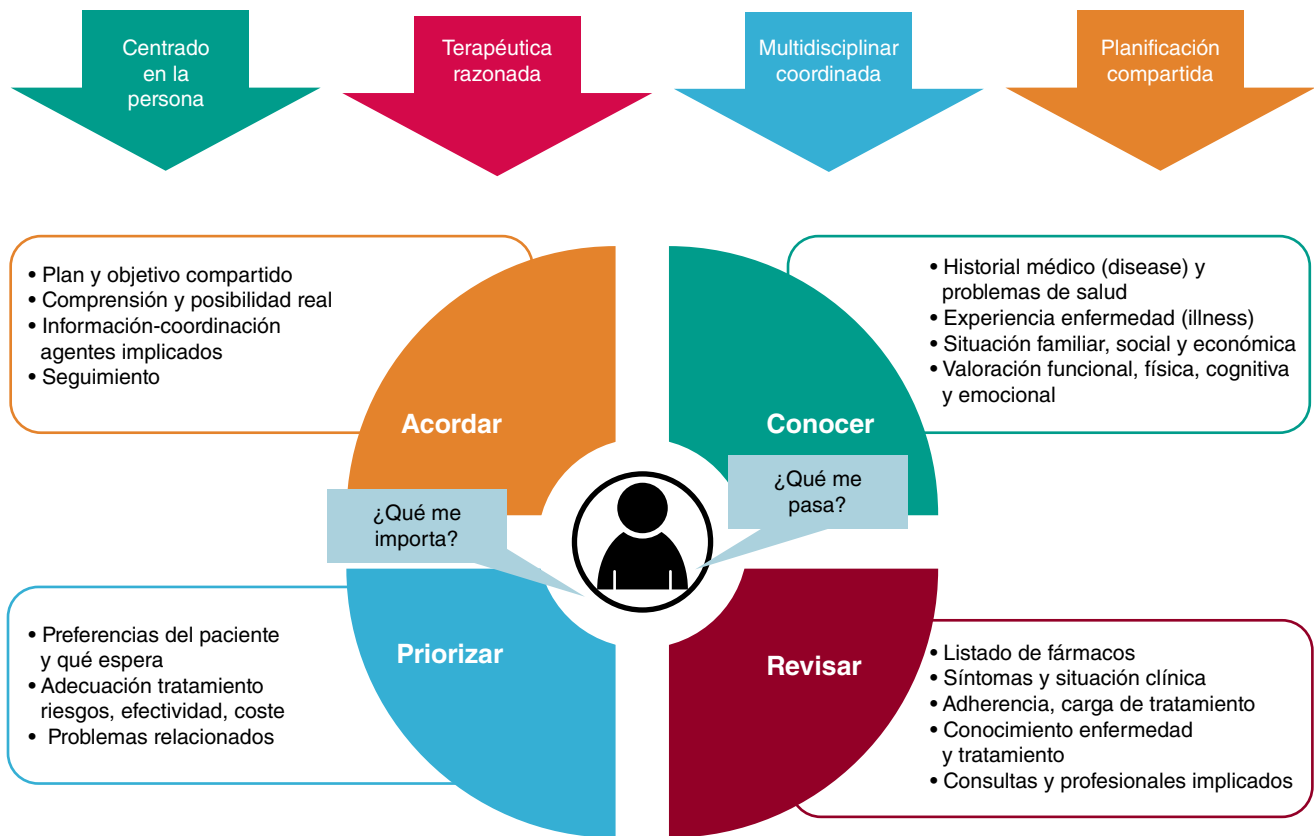


Figura 3. Prescripción centrada en la persona.

Fuente: citas^{26,27, 39 y 41}.

cialmente aquella ligada al tratamiento farmacológico, de pacientes con multimorbilidad^{26,27}. Este modelo propone una evaluación multidimensional (enfermedades, evolución clínica, síntomas, factores socioeconómicos, vulnerabilidad, factores culturales) llevado a cabo por un equipo multidisciplinar, que incorpora las preferencias del paciente, permitiendo mejorar el plan terapéutico y la salud de la persona²⁸.

La PCP, por tanto, es un proceso dinámico que debe ir adaptándose a las diferentes situaciones. Las personas van transitando por escenarios clínicos cambiantes en los que las necesidades preventivas, curativas y paliativas van adquiriendo mayor o menor relevancia²⁹. De forma didáctica describimos cuatro fases. Aunque en la práctica, estas se combinan y solapan formando un proceso circular, en el que la persona debe ser la protagonista, y los diferentes agentes que intervengan se pondrán a su servicio, para *conocer*, *revisar*, *priorizar* y *acordar* (fig. 3). A su vez, estas fases están atravesadas por 4 principios fundamentales, que estarán siempre presentes y que guiarán todo el proceso:

- Centrada en la persona.
- Terapéutica prudente y razonada.
- Multidisciplinar y coordinada.
- Planificación compartida

Centrada en la persona

La atención centrada en la persona (ACP) se basa en el conocimiento acumulado de las personas, lo que proporciona la base para un mejor reconocimiento de los problemas y necesidades de salud a lo largo del tiempo. Se diferencia del modelo centrado en el paciente, que pone el foco en las enfermedades, comorbilidades, visitas y utilización de los servicios³⁰. La ACP se nutre del modelo biopsicosocial, que proporciona una visión global de los pacientes como personas, continuidad asistencial, el conocimiento del contexto e incorporación del individuo como sujeto protagonista del proceso asistencial³¹. Es necesaria una orientación comunitaria, prestando atención a las características socioeconómicas, familiares, laborales, culturales y del apoyo social. Los principios de Ariadne (tabla 3) pueden ser el hilo que ayude a los profesionales a guiar a las personas con multimorbilidad y polimedicación, dentro del laberinto de múltiples consultas y contactos en que habitualmente se encuentran sumidos^{1,32}.

A su vez, una atención eficaz requiere competencia narrativa, es decir, la capacidad de reconocer, absorber, interpretar y actuar sobre las historias y los sufrimientos de los demás. Esto supone escuchar las narraciones del paciente, comprender y respetar sus significados. A partir de ahí podemos ser

TABLA 3. Principios de Ariadne
Evaluar posibles interacciones: las condiciones del paciente, tratamientos, constitución y contexto
• Mantenga una lista de todas las condiciones actuales, evalúe su gravedad e impacto y revise la medicación que se toma actualmente • Vigile activamente los signos de ansiedad, angustia y depresión o disfunción cognitiva, incluidos problemas de adicción y signos o síntomas no específicos como problemas para dormir, pérdida de apetito o problemas de hidratación • Obtenga y considere circunstancias sociales, limitaciones financieras, condiciones de vida y apoyo social, alfabetización en salud, autonomía funcional y estrategias de afrontamiento • Enumere otros médicos y terapeutas involucrados en la atención del paciente y evalúe la carga general del tratamiento
Obtenga preferencias y prioridades: las más importantes para el paciente y resultados menos deseados
• Obtener preferencias por resultados de salud genéricos, como supervivencia, independencia, dolor y alivio de los síntomas, incluido necesidades de cuidados paliativos y ser consciente de las propias (implícitas) preferencias, ya que pueden no ser las mismas que las del paciente • Si corresponde, considere las preferencias de los cuidadores informales o familia • Acordar un objetivo de tratamiento realista con el paciente (y cuidador del paciente, si corresponde)
Individualizar la gestión para alcanzar objetivos del tratamiento negociados
• Sopesar si los beneficios esperados del tratamiento (y prevención) superan las posibles desventajas y daños, dado el nivel de riesgo y las preferencias del paciente individual • Evaluar la carga de tratamiento incremental y combinada del paciente (y el cuidador, si corresponde) • Considerar el autocuidado según las necesidades del paciente y sus capacidades • Proporcionar instrucciones para redes de seguridad, como síntomas de alarma, efectos secundarios y recomendaciones sobre el tratamiento adecuado • Acordar con el paciente el cronograma de visitas de seguimiento para evaluar el logro de objetivos y reevaluar las interacciones • Consultar a otros agentes de atención médica y cuidadores informales que están involucrados con el paciente. Idealmente, todos los agentes involucrados en la atención deberían estar informados sobre las decisiones de tratamiento y tener acceso a la información
Los principios de Ariadne se han desarrollado para apoyar la toma de decisiones compartidas en AP en pacientes con multimorbilidad. Estos principios toman su nombre de la mitología griega, según la cual Ariadna ayudó a Teseo a encontrar la salida del laberinto del Minotauro dándole un ovillo de hilo. Fuente: citas Prados Torres ¹ y Muth et al. ³² .

capaces de intentar responder sus preguntas narrativas: “¿qué me pasa?” “¿por qué me ha ocurrido esto a mí?” y “¿qué será de mí?”. Si no cumplimos con estas tareas narrativas, el diagnóstico puede quedar desenfocado, y la relación clínica puede resultar superficial e ineficaz³³. Aunque tengamos una imagen estática del paciente con multimorbilidad, su vida está repleta de momentos de “crisis” en los que consultan, pero son incapaces de hacerlo de manera ordenada y tranquila como desearíamos los profesionales sanitarios, que queremos oír una narrativa lineal y coherente. Entonces, el paciente tiende a censurarse, con el desafortunado resultado de que los objetivos y tratamientos que le proponemos no son, a menudo, los más adecuados para su realidad. Por el contrario, al escuchar a la persona con empatía e interés, esta compartirá su realidad en toda su complejidad y podrá oír su propia verdad, y el profesional será testigo del caos en la narrativa del paciente³⁴, y tendrá a su disposición el material más útil para poder llevar a cabo una atención eficaz y humana.

Terapéutica prudente y razonada

A menudo es impensable para pacientes y médicos imaginar que una consulta finalice sin una prescripción³⁵. La cultura de la prescripción ha logrado persuadir a pacientes y clínicos de que hay un fármaco para cada problema de salud⁶. Sin embargo, existen propuestas que representan un cambio radical en

las actitudes y conductas relacionadas con la prescripción y que, ironías del destino, han sido denominadas como “prescripción conservadora”, “prescripción prudente” o “razonada”³⁵. La prudencia consiste en el manejo razonable de la incertidumbre³⁶ y es un requisito previo para un uso seguro y adecuado de los medicamentos³⁵. La aplicación de estos principios de prescripción prudente³⁷ es especialmente relevante cuando se trata de personas mayores, con multimorbilidad, fragilidad o esperanza de vida limitada, poco representados en los ensayos clínicos y en los que la aplicación “a rajatabla” de las recomendaciones de las GPC puede producir más daños que beneficios³⁸. Por tanto, es necesario aplicarlos en cada una de las decisiones de tratamiento y también al realizar la REM.

En primer lugar se debe identificar los objetivos terapéuticos globales de los pacientes a través de una valoración contextualizada (tabla 3), así como conocer y priorizar los principales problemas de salud y disponer del listado actualizado completo de los medicamentos que toma el paciente³⁹. Conviene revisar e incluso eliminar los diagnósticos que no contribuyen a reducir el sufrimiento de las personas en un proceso denominado dediagnóstico⁴⁰, que ayuda a reducir el uso excesivo e inadecuado de fármacos y que debe realizarse en estrecha colaboración con el paciente.

Existen distintos algoritmos o herramientas para la REM^{39,41}, no obstante, todas ellas comparten etapas y dimensiones similares^{39,41}. La tabla 4 aborda con más detalle estos aspectos:

- Necesidad/indicación: se debe valorar si los fármacos prescritos son coherentes con los problemas de salud actua-

TABLA 4. Dimensiones y etapas de la revisión estructurada de medicación

Dimensión/etapa	Proceso de evaluación
OBJETIVOS Definir los objetivos terapéuticos: valoración previa contextualizada	- Situación clínica global: problemas de salud, gravedad e impacto, síndromes geriátricos - Social: relaciones formales e informales, limitaciones financieras, condiciones de vida - Funcional (autonomía para ABVD) - Mental: funciones cognitivas y emocionales - Preferencias, expectativas y prioridades en relación a sus resultados de salud y carga de tratamiento (farmacológico o no, citas, analíticas pruebas...)
PROBLEMAS DE SALUD Y TRATAMIENTOS Valorar la coherencia entre objetivos terapéuticos y prescripciones	- Identificar y jerarquizar los problemas de salud, teniendo en cuenta la visión del paciente - Listado actualizado de los fármacos (valorar también adherencia y fármacos que no requieren receta) - Asociar los fármacos al problema de salud - Coherencia entre los objetivos terapéuticos (valoración previa) y el objetivo de la prescripción (prevención primaria y secundaria, sintomático, etiológico, prevenir o tratar daño por otro fármaco, etc...)
NECESIDAD/ INDICACIÓN Identificar fármacos esenciales y fármacos innecesarios	¿Hay algún problema de salud que debería ser tratado con un medicamento y no lo está? (p.ej. persona mayor con anticoagulación + doble antiagregación sin IBP) - Sin indicación vigente (la indicación ha expirado). Ejemplos: hierro en un paciente cuya anemia está bien controlada, estatina en un paciente cuyo pronóstico vital ha cambiado - Indicación no basada en la evidencia (ej: aspirina en prevención primaria) - Sobret ratamiento (p.ej. más de 2-3 antidiabéticos con HbA1c < 7 en paciente con fragilidad, varios antihipertensivos y cifras actualmente adecuadas de PA)
EFFECTIVIDAD Evaluar si se están alcanzando los objetivos terapéuticos	- No está siendo efectivo para el objetivo terapéutico planteado (p.ej. pregabalina añadida al tratamiento analgésico, antimuscarínico urinario para vejiga hiperactiva) - Opción no recomendable y eficaz según la evidencia (p. ej aspirina en prevención primaria) - Se añade un nuevo fármaco sin comprobar la adherencia de los fármacos prescritos - Eficacia marginal: fármacos preventivos en pacientes con expectativa de vida limitada (p.ej. estatinas, bisfosfonatos)
ADECUACIÓN Valorar adecuación según características del paciente. ¿La forma farmacéutica, dosis, pauta y duración adecuadas?	Fármaco, dosis o pauta no apropiado por: - Insuficiencia renal: metformina en FG < 30 ml/min - Edad: zolpidem a dosis de 10 mg/día en > 65 años, carga anticolinérgica excesiva en > 70 años - Duración excesiva: doble antiagregación > 1 año, teriparatida > 2 años, bisfosfonatos > 5 años - Acumulación de fármacos que aumentan en riesgo de caídas en paciente con caídas frecuentes - Administración de formas farmacéuticas inadecuadas en pacientes con problemas de deglución: App Deglufarm
SEGURIDAD Identificar efectos adversos (EA) o riesgos inaceptables /excesivos	- Duplicidades: p.ej. dos benzodiacepinas, dos inhaladores con corticoide inhalado - Contraindicaciones: p.ej. pioglitazona o saxagliptina en insuficiencia cardiaca, sacubitrilo-valsartán en hipotensión o en hiperpotasemia - Efectos adversos: p.ej. hipotensión y síncope por IACE, hiponatremia por ISRS - Interacciones: p.ej. AINE + diurético + IECA/ARA-II (triple whammy) - Riesgos excesivos: p.ej. acumulación de toxicidad por sedación excesiva (p. ej. opioides + gabapentinoides + benzodiacepinas) - Cascadas terapéuticas (p.ej. pregabalina-> edema->diuréticos)
ABVD: actividades básicas de la vida diaria; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; FG: filtrado glomerular; IACE: inhibidores de la acetilcolinesterasa; IBP: inhibidor de la bomba de protones; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; PA: presión arterial. Fuente: Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria ³⁹ y Scottish Government Polypharmacy Model of Care Group ⁴¹	

les y con los objetivos terapéuticos más importantes para los pacientes. Los tratamientos preventivos deben ser revisados, especialmente en los pacientes más frágiles, de mayor edad o con esperanza de vida limitada^{29,41}.

- **Efectividad:** es necesario comprobar si el tratamiento es el más efectivo para los objetivos planteados o existen alternativas mejores (incluyendo las no farmacológicas), o si los fármacos prescritos están siendo suficientemente efectivos. Debe revisarse la adherencia antes de aumentar las dosis o añadir otros fármacos.

- **Adecuación** de cada uno de los medicamentos según la edad, condiciones clínicas (insuficiencia renal o hepática), así como la dosis, forma farmacéutica, pauta y duración.

- **Seguridad:** la presencia de EA puede identificarse por los síntomas del paciente, o por datos de laboratorio. Es ne-

cesario evaluar posibles contraindicaciones, interacciones o cascadas terapéuticas.

El número y complejidad de las herramientas de ayuda a la prescripción (tabla 5) es cada vez mayor y por tanto para su uso efectivo es necesario su integración en la historia clínica electrónica⁴², de forma que permitan el cribado de PPI, interacciones, duplicidades y riesgos.

Multidisciplinar, integral y coordinada

Todo este proceso debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar, constituido habitualmente por profesionales de

TABLA 5. Selección de herramientas de ayuda a la prescripción**CRITERIOS EXPLÍCITOS**

Se basan en criterios preestablecidos, son fiables, fáciles de implementar en la práctica y de integrar en las herramientas de ayuda a la prescripción electrónica asistida. Los criterios explícitos detectan el uso inapropiado de medicamentos o que deben evitarse en determinadas patologías o situaciones clínicas concretas. La información que recogen está más centrada en el medicamento que en el paciente

STOPP/START versión 3 en castellano (2023)
<https://doi.org/10.1016/j.regg.2023.101407>

Criterios sobre el uso de medicamentos potencialmente inapropiados (133 criterios STOPP) y potenciales omisiones de prescripción (57 criterios START) en personas mayores

BEERS (2023)
<https://doi.org/10.1111/jgs.18372>

Criterios de la American Geriatrics Society para el uso de medicamentos potencialmente inapropiados en personas mayores

STOPPFrail versión 1 en castellano 2018 (STOPP-PAL)
<https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.11.008>

Herramienta para facilitar decisiones de deprescripción en personas mayores con pronóstico de vida limitado (STOPP-PAL en castellano)

STOPPFrail versión 2. 2020 (inglés)
<https://doi.org/10.1093/ageing/afaa159>

Less Chron
 (List of Evidence-based depreScribing for CHRONic patients)
<https://doi.org/10.1111/ggi.13062>

Listado de medicamentos y situaciones clínicas que suponen una oportunidad para la deprescripción en pacientes pluripatológicos

EVOLV-Rx
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.48599>

Conjunto de indicadores para detectar y reducir la prescripción de bajo valor en personas mayores

CRITERIOS IMPLÍCITOS

Parten de una evaluación clínica del paciente y su medicación a partir de los cuales se realiza un juicio clínico de si los fármacos prescritos son o no adecuados

MAI. Medication Appropriateness Index
<https://doi.org/10.1007/s40266-013-0118-4>

El índice de adecuación de la medicación (MAI) mide la idoneidad de la prescripción de pacientes mayores, utilizando 10 criterios para cada medicamento prescrito

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE APOYO A LAS DECISIONES CLÍNICA

MEDSTOPPER
<https://medstopper.com/>

Herramienta que genera recomendaciones de suspensión o modificación de tratamientos para pacientes concretos

MEDSAFER
<https://www.medsafer.org/>

Herramienta de apoyo a la deprescripción

OTROS RECURSOS

Deprescribing.org
<https://deprescribing.org/>

Página que recoge recursos, herramientas y abordajes de apoyo a la deprescripción

NNT
<https://thennt.com/>

Resúmenes concisos de la evidencia que traducen los resultados de los estudios a NNT

Fuente: Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria³⁹ y World Health Organization⁶².

medicina, enfermería, farmacia, trabajo social, otros clínicos y de la propia comunidad según las preferencias del paciente y la organización de cuidados. Dada la complejidad de los pacientes con multimorbilidad, caracterizada por una evolución dinámica y variable que requieren de una monitorización continua, no serán suficientes aquellas aproximaciones basadas en intervenciones puntuales. Por tanto, resulta necesaria una atención integral, integrada (estableciendo alianzas con otros agentes) y coordinada entre los profesionales asistenciales, y por supuesto contando con el paciente y sus familiares y/o cuidadores, que asegure una correcta continuidad asistencial. Resulta fundamental establecer objetivos comunes y transversales para que las organizaciones y sus profesionales trabajen de forma coordinada, independientemente del ámbito y nivel asistencial (hospital, atención primaria, sociosanitaria).

Tanto las médicas de AP como las FAP realizarán seguimiento conjunto, monitorización de los cambios realizados y/o modificaciones en el tratamiento y/o propuesta de nuevas prescripciones. En cuanto a las FAP como, asesoras, formadoras y dinamizadoras de los procesos vinculados a la mejora de la seguridad de los tratamientos en los pacientes con multimorbilidad, sus funciones se centrarían en la conciliación, y la REM para la mejora de la adecuación de los fármacos. Como parte del equipo de cuidados de los pacientes enfermería tendría una función clave en la prevención de enfermedades crónicas, así como en el buen desarrollo, cumplimiento y seguimiento del plan terapéutico, la gestión de pacientes, y el manejo y resolución de problemas con la medicación.

En cualquier caso, las medidas no pueden limitarse al sistema sanitario exclusivamente, es preciso la implementación

TABLA 6. Proceso de toma de decisiones compartidas

PROCESO DE TOMA DECISIONES COMPARTIDAS
1. GENERAR UN CLIMA DE CONFIANZA Desarrollar una relación de confianza con el paciente, ofreciendo empatía y calidez. Es importante que exista una comunicación fluida y facilitar el discurso del paciente
2. CONOCER EL DESEO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN • Explorar y determinar las preferencias del paciente sobre la información que desea recibir (formato, cantidad...) • Explorar y determinar las preferencias del paciente acerca de su papel en la toma de decisión (como el riesgo que quieren asumir o el nivel de participación tanto suya como de amigos o familiares)
3. CONOCER EL PUNTO DE VISTA DEL PACIENTE Comprobar y responder a las ideas, preocupaciones y expectativas de los pacientes (como por ejemplo sobre las opciones de manejo de la enfermedad) atendiendo a las «pistas» que estos proporcionan
4. DETERMINAR LAS OPCIONES Identificar las opciones (incluyendo las ideas y la información que el paciente pueda tener) y valorar la evidencia en el contexto del paciente individual, sin olvidar que no hacer nada también es una opción
5. PROCESO DE DELIBERACIÓN Presentar la evidencia y ayudar al paciente a reflexionar, trabajar ambivalencias y evaluar el impacto de las alternativas en relación con sus valores y preferencias Tomar o negociar la decisión en conjunto con el paciente y resolver posibles conflictos
6. PLANIFICAR Acordar un plan de acción y preparar el seguimiento

Fuente: Bomhof-Roordink et al.⁵⁴.

de políticas públicas que mejoren el bienestar y la equidad en salud para lo que se requiere del compromiso y la implicación activa de otros sectores, para desarrollar acciones intersectoriales. Por tanto, es necesario involucrar a toda la comunidad, y como muestra de ello cabe señalar la relevancia de las campañas de concienciación sobre los riesgos de la polimedicación⁴³⁻⁴⁶. Resultan útiles iniciativas de información sobre medicamentos⁴⁷ o campañas como “Pastillas las justas”⁴⁸ que fomentan conversaciones entre pacientes y profesionales sanitarios, promoviendo que las personas se involucren en su propio cuidado y en el uso más seguro y efectivo de los medicamentos.

Planificación compartida

Montori en su “Revolución del paciente”⁴⁹ propone que la atención que los pacientes necesitan es aquella que deje la menor huella posible en sus vidas. En muchas ocasiones, se les pide a los pacientes un número de tareas que implican realizar cambios en su estilo de vida, aprender y monitorizar tratamientos y buscar el sostén de otras personas (control de la tensión, del peso, glucemia, caminar 45 minutos al día, dietas, regímenes de fármacos complejos con horarios diferenciados a lo largo del día...), que sobrepasan su capacidad real y sus capacidades (físicas, mentales, sociales, económicas...). Cuando esto ocurre se les suele etiquetar de “incumplidores”, lo cual sucede con mayor frecuencia en las personas más vulnerable o frágiles. No es que no quieran cumplirlas, sino que no viven solamente para ser pacientes *modelos*.

La toma de decisiones compartida (TDC) es un proceso de colaboración que implica que una persona y su profesional de la salud trabajen juntos para llegar a una decisión conjunta sobre la atención, ya sea inmediata o futura (p.ej., a través de la planificación anticipada). Implica tomar las decisiones basadas tanto en la evidencia, como en las preferencias, creencias y valores individuales de la persona, asegurando que entiende los riesgos, beneficios y posibles consecuencias de las diferentes opciones, a través de la discusión y el intercambio de información⁵⁰. De esta manera, se capacita y posibilita a las personas para tomar decisiones sobre la atención que es adecuada para ellas en ese momento (incluyendo también la opción de elegir no cambiar lo que están haciendo actualmente), siendo un proceso abierto y dinámico. Lamentablemente, esto no suele ocurrir de forma inmediata, ya que para conseguir una participación efectiva se necesita de un gran cambio cultural que consiga revertir la expropiación de la salud⁵¹ sufrida por la población en las últimas décadas⁵².

Existen distintos modelos de TDC, aunque la mayoría comparten los siguientes aspectos: aprender sobre el paciente y sus preferencias, dar información personalizada, deliberar y crear conciencia de la elección^{53,54} (tabla 6). Disponemos de evidencia acerca de la efectividad de la TDC en AP para mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y las opciones de los pacientes, reducir el conflicto de toma de decisiones y fomentar la satisfacción del paciente con el proceso de decisión y la elección final⁵⁵. Sin embargo, todavía son pocos los profesionales que exploran las preocupaciones y objetivos de los pacientes, destinando al paciente una parte muy breve de la entrevista para exponer su historia, interrumpiéndola en la mayoría de ocasiones a los pocos segundos⁵⁶.

Historias que nos sirven para aprender y reflexionar

La vida está llena de historias. Historias de salud y de enfermedad, que nos sirven para aprender y reflexionar⁵⁷. La historia de Carmen es una historia única, y solo pretende servirnos de ejemplo práctico, aproximándonos a su realidad y contexto, conociendo sus preferencias y preocupaciones, y en definitiva poniendo en práctica la PCP (tablas 7 y 8) podemos adecuar su tratamiento a lo que ella quiere y necesita realmente (tabla 9).

Conclusión

Sin duda alguna, uno de los principales retos de los sistemas sanitarios es ofrecer una adecuada atención a los pacientes

con multimorbilidad y polimedicación. Han transcurrido dos décadas desde que se alzaran las primeras voces advirtiendo de los posibles daños derivados de aplicar una atención basada en la enfermedad a personas mayores con multimorbilidad⁵⁸. Hay evidencia acumulada acerca de las consecuencias negativas de la polimedicación inapropiada, pero su prevalencia sigue aumentando. Es un imperativo poner el foco en su *prevención*, a través de una terapéutica prudente y razonada que tenga en cuenta el contexto y la opinión de las personas, promover las REM y la deprescripción como prácticas cotidianas, y sin olvidar que “la mejor deprescripción es aquella que no se llega a hacer⁵⁹, por no ser necesaria”. Para todo esto, necesitamos cambios culturales tanto dentro del sistema sanitario como en la sociedad que promuevan la implicación de la población en su propio cuidado y en el mejor uso de los medicamentos. Finalmente, cabe destacar la im-

TABLA 7. Listado de medicamentos de Carmen			
Cardiovascular	Analgesia	Insulina/Inhala	Otros
A) Ácido acetilsalicílico 100 mg 0-1-0	J) Hidromorfona 4 mg 1-0-1	O) Insulina mixta 30 15-15-0	S) Pantoprazol 80 mg 1-0-0
B) Doxazosina 8 mg 0-0-1	K) Hidromorfona 8 mg 1-0-1	P) Insulina detemir 0-0-40	T) Lormetazepam 1 mg 0-0-2
C) Bisoprolol 5 mg 1-0-0	L) Metamizol 575 mg 1-1-1	Q) Beclometasona 200 mcg/ formoterol 6 mcg polvo inhalación 1-0-1	
D), E), F) Amlodipino/ valsartán/ hidroclorotiazida 10/320/25 mg 1-0-0	M) Paracetamol 1 g 1-1-1	R) Terbutalina 500 mcg polvo inhalación 1-1-1	
G) Atorvastatina 80 mg 0-0-1	N) Pregabalina 25 mg 1-0-1		
H) Ezetimiba 10 mg 0-0-1			
I) Furosemida 40 mg 1-0-0			

TABLA 8. Prescripción centrada en Carmen	
CONOCER	
• Carmen vive en un caserío con su marido Luis, tienen tres hijos, y 3 nietos. Su vida ha sido la familia, los hijos, el caserío, y el restaurante, famoso por sus alubias que tantas personas han degustado a lo largo de las últimas décadas • Cuenta con un amplio historial médico, que incluye varios ingresos hospitalarios (fig. 2). • Carmen se vale por sí misma y se ocupa también de Luis. No obstante, en los últimos años le cuesta más subir las escaleras de casa, y dada esta disnea de origen multifactorial sale menos de casa. No le resulta fácil aceptar su situación, y muchos días expresa enfado y tristeza por ello • En cierto modo muestra cansancio respecto a sus múltiples problemas de salud y las tareas derivadas de las mismas: “Llevo toda la vida entre médicos” y “muchas veces me pregunto si tomar tantas pastillas realmente merece la pena”	
REVISAR	
• Le pedimos a Carmen que venga a la consulta con sus medicamentos en la bolsa “marrón”, y de la misma saca otras bolsas de plástico: “En esta bolsa tengo las de la mañana. En esta otra las de la noche. Las de la comida, las insulinas y los inhaladores los tengo aparte...”. Explica qué es lo que toma, cómo y para qué sirven las pastillas. Hace una demostración de completo conocimiento y control sobre la medicación. Además de las suyas, se encarga de todas las boticas de su marido. • Se revisa su listado de problemas de salud y el grado de control. En cuanto a la diabetes mellitus muestra un adecuado control metabólico, HbA1c 7,5%; no ha presentado nuevos eventos cardiovasculares desde hace más de 10 años • Preguntándole por aquellos problemas de salud que más le preocupan: “El dolor y la fatiga que siento cuando me muevo” • También se revisa el listado completo de los medicamentos de Carmen, tal como se recoge en la tabla 7 • Aunque no suele venir demasiado a la consulta, la MF y la enfermera del equipo de AP están pendientes de Carmen, y aprovechan las visitas que hacen a Luis (control de INR) para saber de ella. Carmen recoge los fármacos en la farmacia del pueblo, aunque últimamente suele mandar a la hija. Hace años que le dieron el alta de Endocrinología, pero actualmente sigue control en Cardiología, Neumología y la Unidad del Dolor	

(Continúa)

TABLA 8. Prescripción centrada en Carmen (continuación)

PRIORIZAR
- La FAP que valore la adecuación de los fármacos de Carmen. Para ello empleará la información clínica disponible en la HCE (diagnósticos, analíticas...) así como diferentes herramientas de ayuda a la prescripción (tabla 6), valorando así la presencia de fármacos potencialmente inadecuados, la carga anticolinérgica y las interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad. A su vez, se valorará la posibilidad de desintensificar ciertos tratamientos y objetivos terapéuticos (grado de control metabólico en relación a la diabetes y la hipertensión), y la simplificación del régimen terapéutico (diferentes dispositivos de insulinas, por ejemplo) - Compartimos con Carmen el informe emitido por la FAP que muestra los fármacos inapropiados, las interacciones y los problemas relacionados con la medicación. Se le propone la retirada de doxazosina y ezetimiba, al tiempo que se emiten otras recomendaciones (tabla 9) - Las experiencias y creencias acerca de los fármacos pueden ser facilitadores o barreras para su retirada por lo que deben ser considerados: “dudo que me haga mucho efecto”; “llevo muchos años tomándola y el dolor seguía ahí” (pregabalina); “tampoco creas que duermo demasiado” (lormetazepam); y “tanto pinchazo y cachivache es complicado” (insulinas e inhaladores) - Le preguntamos a Carmen por las medidas no farmacológicas para mejorar el control de la tensión arterial, los lípidos y el dolor (movimiento, pérdida de peso...), y responde que llegada la primavera le gustaría salir más a pasear
ACORDAR
- A Carmen le gusta la idea de intentar reducir la cantidad de fármacos que está tomando, y se siente acompañada y segura, sabiendo que si empeora se podrían volver a introducir. - Proponemos ir reduciendo de forma progresiva la pregabalina y el lormetazepam, primero uno y después el otro. Es muy importante dejar que Carmen marque el ritmo, no forzar en ningún momento ni intentar acelerar el proceso. Le proporcionamos la información por escrito, y en el caso del lormetazepam proporcionamos una hoja para su reducción gradual - Dejamos la puerta abierta a la posibilidad de retirar la ezetimiba y la doxazosina. A Carmen le preocupa lo que le pueda decir el cardiólogo en la próxima visita con él. Le proponemos la posibilidad de entregarle una carta justificando la decisión, y aprovechar la siguiente analítica para monitorizar los cambios. A su vez, le proponemos que realice un AMPA y así comprobar los cambios que pueda - Escribimos los acuerdos y los ajustes del tratamiento en la historia clínica y en la receta electrónica, dándole una copia impresa de la hoja del tratamiento consensuado a Carmen - Finalmente, concertamos una visita para dentro de un mes, en esta ocasión nos acercaremos a su caserío que se encuentra en un lugar precioso con unas vistas maravillosas
AMPA: automedida de la presión arterial; AP: atención primaria; FAP: farmacéutica de atención primaria; HCE: historia clínica electrónica; MF: médica de familia.

TABLA 9. Recomendaciones emitidas por la farmacéutica de AP

Informe emitido por FAP con fármacos inadecuados y recomendaciones
- Ante la toma de varios antihipertensivos debe considerarse el riesgo de hipotensión y caídas. Recomienda suspender la doxazosina, por el alto riesgo de hipotensión ortostática, además por su carga anticolinérgica - Ante el buen control glucémico en DM2 y el cansancio de Carmen con los pinchazos, valorar desintensificar el tratamiento con insulinas, dejando una única insulina basal, y plantear alternativas con antidiabéticos orales, más cómodas y con menor riesgo de hipoglucemias - Recomienda suspender la ezetimiba e incluso reducir la dosis de atorvastatina de 80 mg. Existe potenciación entre ambos fármacos (riesgo de toxicidad, miopatías). Después de más de 5 años del evento coronario agudo, presentando un aceptable perfil lipídico, parece que el balance beneficio-riesgo resulta desfavorable para esta combinación de fármacos - Grupo de psicofármacos: hidromorfona, pregabalina, lormetazepam, interacciones de alto riesgo, por lo que sugiere retirada gradual según posibilidades clínicas. En todos los casos se recomienda reducción gradual y progresiva de estos fármacos para evitar síntomas de retirada. Asegurarse de que tiene prescritos laxantes para el estreñimiento provocado por los opioides - No se recomienda el uso a largo plazo de metamizol porque aumenta el riesgo de agranulocitosis. Por otra parte, puede provocar reacciones de hipotensión severa, así como reducir la eficacia del AAS. Además, lo recoge muy pocas veces de la farmacia - En cuanto a pantoprazol 80 mg, existen discrepancias en la aportación del uso generalizado de un IBP en la profilaxis de gastropatía por AAS en personas mayores, pero, en cualquier caso, se debería utilizar a dosis menores, por lo que se recomienda sustituir por omeprazol 20 mg para disminuir el riesgo de fracturas osteoporóticas, hipomagnesemia o déficit de hierro y vitamina B12, entre otros

TABLA 10. Glosario de términos
Atención centrada en la persona: modelo de atención sanitaria que pone a la persona en el centro del sistema, con el objetivo de mejorar su salud, calidad de vida y bienestar, respetando su dignidad y derechos, así como a sus necesidades, preferencias, valores y experiencias, y contando con su participación activa ya que debe considerarse como un igual en la planificación, el desarrollo y la evaluación en el proceso de atención. Este es el modelo de atención que debería aplicarse a los pacientes frágiles y/o con complejidad clínica
Fragilidad: es un estado clínico en el que la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar mayor dependencia y/o mortalidad está incrementada cuando se expone a un factor de estrés (procesos agudos o crónicos, condiciones físicas y psíquicas, inactividad, factores socioeconómicos, etc.)
Comorbilidad: es la coexistencia de patologías adicionales a una patología índice, considerada principal. Esta enfermedad principal es el foco de todas las estrategias que se llevarán a cabo en estas personas, aunque su evolución y respuesta terapéutica se verá condicionada por la presencia de otras enfermedades. La medida de comorbilidad más conocida es el Índice de Charlson
Multimorbilidad: es la coexistencia de dos o más patologías crónicas que afectan a sistemas orgánicos diferentes. Por consenso, a este término debe incorporarse también la gravedad de las patologías. Uno de los instrumentos validados y utilizados en la atención primaria para medirla es el Cumulative Illness Rating Score (CIRS), que incluye 14 dominios anatómicos con 4 niveles de gravedad
Prevención cuaternaria: es el conjunto de actividades que intentan evitar los efectos iatrogénicos o perjudiciales de la propia acción preventiva, diagnóstica y terapéutica provocada por la intervención médica y es especialmente relevante en el paciente de edad avanzada
Revisión estructurada de la medicación (REM): se define como la evaluación crítica y estructurada del régimen terapéutico completo de un paciente, con el fin de optimizar su impacto sobre la salud y minimizar los riesgos asociados a la polimedización. Tiene en cuenta el contexto de la persona
Deprescripción: retirada o reducción supervisada por un profesional médico de fármacos inapropiados, cuyo daño potencial supera el beneficio o aquellos que no son compatibles con los objetivos de salud del paciente. El objetivo de la deprescripción es mantener o mejorar la calidad de vida. La deprescripción es el proceso de retirar una mediación inapropiada, supervisada por un profesional sanitario, con el objetivo de gestionar la polimedización y mejorar los resultados
Reacción adversa a medicamentos (RAM): una RAM es cuando se produce una lesión por tomar uno o más medicamentos. Incluyen reacciones o efectos secundarios graves a los medicamentos, errores de medicación, reacciones alérgicas y sobredosis
Polimedización: término utilizado en la literatura científica para describir la condición de tomar múltiples medicamentos. Generalmente definida por el uso de 5 o más fármacos de forma crónica (diariamente durante tres o más meses), y polimedización extrema (hiperpolimedización) a 10 o más medicamentos, aunque el límite varía porque no existe consenso. La polimedización puede ser útil o perjudicial, dependiendo de las condiciones del paciente y los medicamentos específicos
Toma de decisiones compartida: es un proceso de colaboración que implica que una persona y su profesional de la salud trabajen juntos para llegar a una decisión conjunta sobre la atención, ya sea inmediata o futura (p.ej., a través de la planificación anticipada). Implica tomar las decisiones basadas tanto en la evidencia, como en las preferencias, creencias y valores individuales de la persona, asegurando que entienda los riesgos, beneficios y posibles consecuencias de las diferentes opciones, a través de la discusión y el intercambio de información. De esta manera, se capacita y posibilita a las personas a ser participantes activos en la toma de decisiones sobre la atención que es adecuada para ellas en ese momento

portancia de compartir historias y experiencias a través de las cuales poder ir aprendiendo y mejorando nuestra práctica^{60,61} en relación con la multimorbilidad y la polimedización, siempre centradas en la persona.

En la tabla 10 se incluye un glosario de términos que pueden resultar útiles para facilitar la lectura de este artículo.

Bibliografía

1. Prados-Torres A, del Cura-González I, Prados-Torres JD, Leiva-Fernández F, López-Rodríguez JA, Calderón-Larranaga A, et al. Multimorbilidad en medicina de familia y los principios Ariadne. Un enfoque centrado en la persona. Aten Primaria. 2017;49(5):300-7.

2. Prados-Torres A, Poblador-Plou B, Gimeno-Miguel A, Calderón-Larranaga A, Poncel-Falcó A, Gimeno-Feliú LA, et al. Cohort Profile: The Epidemiology of Chronic Diseases and Multimorbidity. The EpiChron Cohort Study. International Journal of Epidemiology. 2018;47(2):382-4.

3. Gnjjidic D, Hilmer SN, Blyth FM, Naganathan V, Waite L, Seibel MJ, et al. Polypharmacy cutoff and outcomes: five or more medicines were used to identify community-dwelling older men at risk of different adverse outcomes. J Clin Epidemiol. 2012;65(9):989-95.

4. Stewart D, Mair A, Wilson M, Kardas P, Lewek P, Alonso A, et al. Guidance to manage inappropriate polypharmacy in older people: systematic review and future developments. Expert Opin Drug Saf. 2017;16(2):203-13.

5. Anderson K, Stowasser D, Freeman C, Scott I. Prescriber barriers and enablers to minimising potentially inappropriate medications in adults: a systematic review and thematic synthesis. BMJ open. 2014;4(12):e006544.

6. The Lown Institute. Medication overload: America's other drug problem. 2019 Disponible en: <https://lowninstitute.org/reports/medicationoverload-americas-other-drug-problem/>

7. Liew TM, Lee CS, Goh SKL, Chang ZY. The prevalence and impact of potentially inappropriate prescribing among older persons in primary care settings: multilevel meta-analysis. Age ageing. 2020;49(4): 570-9.

8. Mangin D, Bahat G, Golomb BA, Mallery LH, Moorhouse P, Onder G, et al. International Group for Reducing Inappropriate Medication Use & Polypharmacy (IGRIMUP): Position Statement and Ten Recommendations for Action. Drugs Aging. 2018;35:575-87.

9. Kongkaew C, Hann M, Mandal J, Williams SD, Metcalfe D, Noyce PR, et al. Risk factors for hospital admissions associated with adverse drug events. Pharmacotherapy. 2013;33(8):827-37.

10. Li Y, Zhang X, Yang L, Yang Y, Qiao G, Lu C, et al. Association between polypharmacy and mortality in the older adults: A systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2022;100:104630.

11. Klarin I, Wimo A, Fastbom J. The association of inappropriate drug use with hospitalisation and mortality: a population-based study of the very old. Drugs aging. 2005;22:69-82.

12. Khezrian M, McNeil CJ, Murray AD, Myint PK. An overview of prevalence, determinants and health outcomes of polypharmacy. Ther Adv Drug Saf. 2020;11, 2042098620933741.

13. Hernández-Rodríguez MÁ, Sempere-Verdú E, Vicens-Caldentey C, González-Rubio F, Miguel-García F, Palop-Larrea V, et al. Evolution of

- polypharmacy in a spanish population (2005-2015): A database study. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*. 2020;29(4):433-43.
14. Cebrino J, Portero de la Cruz S. Polypharmacy and associated factors: a gender perspective in the elderly Spanish population (2011–2020). *Front Pharmacol*. 2023;14:1189644.
 15. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. *Lancet*. 2012;380(9836):37-43.
 16. Doherty AJ, Boland P, Reed J, Clegg AJ, Stephani AM, Williams NH, et al. Barriers and facilitators to deprescribing in primary care: a systematic review. *BJGP Open*. 2020;4(3).
 17. Al Bulushi S, McIntosh T, Grant A, Stewart D, Cunningham S. Implementation frameworks for polypharmacy management within healthcare organisations: a scoping review. *Int J Clin Pharm*. 2023;45(2):342-54.
 18. Lee JQ, Ying K, Lun P, Tan KT, Ang W, Munro Y, et al. Intervention elements to reduce inappropriate prescribing for older adults with multimorbidity receiving outpatient care: A scoping review. *BMJ Open*. 2020;10(8).
 19. Ali MU, Sherifali D, Fitzpatrick-Lewis D, Kenny M, Lamarche L, Raina P, et al. Interventions to address polypharmacy in older adults living with multimorbidity: Review of reviews. *Can Fam Physician*. 2022;68(7):e215-e26.
 20. Anderson LJ, Schnipper JL, Nuckols TK, Shane R, Sarkisian C, Le MM, et al. A systematic overview of systematic reviews evaluating interventions addressing polypharmacy. *Am J Health Syst Pharm*. 2019;76(21):1777-87.
 21. Cole JA, Gonçalves-Bradley DC, Alqahtani M, Barry HE, Cadogan C, Rankin A, et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023;10(10):CD008165.
 22. Rankin A, Cadogan CA, Patterson SM, Kerse N, Cardwell CR, Bradley MC, et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023;9(9):CD008165.
 23. Omuya H, Nickel C, Wilson P, Chewning B. A systematic review of randomised-controlled trials on deprescribing outcomes in older adults with polypharmacy. *Int J Pharm Pract*. 2023;31(4):349-68.
 24. Croke A, Cardwell K, Clyne B, Moriarty F, McCullagh L, Smith SM. The effectiveness and cost of integrating pharmacists within general practice to optimize prescribing and health outcomes in primary care patients with polypharmacy: a systematic review. *BMC Prim Care*. 2023;24(1):41.
 25. Radcliffe E, Servin R, Cox N, Lim S, Tan QY, Howard C, et al. What makes a multidisciplinary medication review and deprescribing intervention for older people work well in primary care? A realist review and synthesis. *BMC Geriatr*. 2023;23(1):591.
 26. Espauella-Panicot J, Molist-Brunet N, Sevilla-Sánchez D, González-Bueno J, Amblàs-Novellas J, Solà-Bonada N, et al. Modelo de prescripción centrado en la persona para mejorar la adecuación y adherencia terapéutica en los pacientes con multimorbilidad. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2017;52(5):278-81.
 27. Rovira C, Modamio P, Pascual J, Armengol J, Ayala C, Gallego J. Person-centred care provided by a multidisciplinary primary care team to improve therapeutic adequacy in polymedicated elderly patients (PCMR): randomised controlled trial protocol. *BMJ Open*. 2022;12:e051238.
 28. Heaton J, Britten N, Krska J, Reeve J. Person-centered medicines optimisation policy in England: an agenda for research on polypharmacy. *Prim Heal Care Res Dev*. 2017;18:24-34.
 29. Infac. Cuidados Paliativos. Boletín Infac. 2016;24(9):52-58. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2016/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_24_n_9_cuidados%20paliativos.pdf
 30. Starfield B. Is patient-centered care the same as person-focused care? *Perm J*. 2011;15(2):63-9.
 31. Turabian JL, Pérez-Franco B. Grandes misterios. ¿Puedes ver al monstruo del lago Ness?: el modelo biopsicosocial y las actividades comunitarias. *Aten Primaria*. 2007;39(5):261-4.
 32. Muth C, van den Akker M, Blom JW, Mallen CD, Rochon J, Schellevis FG, et al. The Ariadne principles: how to handle multimorbidity in primary care consultations. *BMC*. 2014;12(1):1-11.
 33. Charon R. The patient-physician relationship: narrative medicine: a model for empathy, reflection, profession and trust. *JAMA*. 2001;286:1867-902.
 34. Valverde C. ¿Quién está escuchando? La narrativa del paciente, caos y cronicidad. *Aten Primaria*. 2005; 36(3):159.
 35. Schiff GD, Galanter WL, Duhig J, Lodolce AE, Koronkowski MJ, Lambert BL. Principles of conservative prescribing. *Arch Intern Med*. 2011;171(16):1433-40.
 36. Marijuan M. Ética de la prescripción. *Infac*. 2003;11(3):11-6. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2003/es_def/adjuntos/infac_v11_n3.pdf
 37. Gavilán E, Villafaina A, Garzón J, Herrero J, Jiménez J de. Prescripción de medicamentos. Formación Médica Continuada en Atención Primaria. 2015;22(3):9-32.
 38. Garfinkel D. Poly-De-prescribing vs Polypharmacy-The Weapon to Fight an Iatrogenic Epidemic: An Overview. *European J of Geriatrics and Gerontology*. 2019;1(1):1-10.
 39. Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP). Posicionamiento SEFAP en la revisión de la medicación centrada en la persona. [Internet]. 2020; [consultado 14 Oct 2023]. Disponible en: <https://www.sefap.org/wp-content/uploads/2022/06/POSICIONAMIENTO-REVISION-MEDICACION-C3%93N.pdf>
 40. Lea M, Hofmann BM. Dediagnosing – a novel framework for making people less ill. *Eur J Intern Med*. 2022;95:17-23.
 41. Scottish Government Polypharmacy Model of Care Group. Scottish Government Polypharmacy Model of Care Group. Polypharmacy Guidance, Realistic Prescribing 3rd Edition, 2018. Scottish Government 2018. Disponible en: <https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/04/Polypharmacy-Guidance-2018.pdf>
 42. Actualización de los criterios STOPP/START, versión 3. Reseña y traducción al español.[Internet]. 2023; [consultado 10 Oct 2023].<https://sano-y-salvo.blogspot.com/2023/08/actualizacion-de-los-criterios.html>
 43. Turner JP, Currie J, Trimble J, Tannenbaum C. Strategies to promote public engagement around deprescribing. *Ther Adv Drug Saf*. 2018; 9(11): 653-65.
 44. Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. *JAMA Intern Med*. 2014;174(6): 890-8.
 45. Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S, Tannenbaum C. Effect of a pharmacist-led educational intervention on inappropriate medication prescriptions in older adults: The d-prescribe randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;320(18):1889-98.
 46. Dollman W, Leblanc V, Stevens L, O'Connor P, Roughead EE, Gilbert A. Achieving a sustained reduction in benzodiazepine use through implementation of an area-wide multi-strategic approach. *J Clin Pharm Ther*. 2005; 30(5):425-32.
 47. Departamento de Salud. Gobierno vasco. Ibotika- Información de Medicamentos. [Internet]. [consultado 7 Sep 2023] Disponible en: <https://www.euskadi.eus/informacion-medicamentos-ibotika/>
 48. OCU - NO GRACIAS – POLIMEDLABS. Pastillas las Justas. [Internet] [consultado 27 Sep 2023] Disponible en: <http://pastillaslasjustas.org/>
 49. Montori V. Por Qué Nos Rebelamos: la revolución del paciente por una atención cuidadosa y gentil. *Patient Revolution*. 2019. 206 páginas.
 50. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Shared decision making (NG 197 [Internet] London: NICE; 2021 [actualizado Oct 2021; consultado 22 Oct 2203] Disponible en: www.nice.org.uk/guidance/ng197
 51. Illich I. Némesis médica. La expropiación de la salud. Barral Editores; 1975. 218 páginas.
 52. Gervas J, Pérez-Fernández M. La Expropiación de la Salud. Los libros del Lince.2015; 246 páginas.
 53. Bomhof-Roordink H, Gärtner FR, Stiggelbout AM, Pieterse AH. Key components of shared decision making models: a systematic review. *BMJ Open*. 2019; 17:9(12):e031763.
 54. Infac. Participación de los pacientes en la toma de decisiones. 2014; 22(3):12-17. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_n_3_Decisiones_compartidas.pdf
 55. Coronado-Vázquez V, Canet-Fajas C, Delgado-Marroquín MT, Magallón-Botaya R, Romero-Martín M, Gómez-Salgado J. Interventions to facilitate shared decision-making using decision aids with patients in Primary Health Care: A systematic review. *Medicine (Baltimore)*. 2020; 99(32):e21389.
 56. Singh Ospina N, Phillips KA, Rodriguez-Gutierrez R, Castaneda-Guarderas A, Gionfriddo MR, Branda ME, et al. Eliciting the Patient's Agenda- Secondary Analysis of Recorded Clinical Encounters. *J Gen Intern Med*. 2019;34(1):36-40.

57. Baza M, Santos N, Garzón J (coord.). Polimediarte. Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud. 2014; 162 páginas.
58. Boyd CM, Darer J, Boult C, Fried LP, Boult L, Wu W. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases: implications for pay for performance. *JAMA*. 2005;294(6): 716-24.
59. Jiménez E, Arroyo Anié MP, Vicens Caldentey C, González Rubio F, Hernández Rodríguez MÁ, Sempere Manuel M. Deprescribiendo para mejorar la salud de las personas o cuando deprescribir puede ser la mejor medicina. *Aten Primaria*. 2018;50:70-9.
60. Scottish Government Polypharmacy Model of Care Group. Case study. [Internet] [consultado 12 Oct 2023] Disponible en: <https://www.polypharmacy.scot.nhs.uk/for-healthcare-professionals/case-studies/>
61. World Health Organization. Medication Safety in Polypharmacy. Annex 4. Case studies: 2019. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHC-SDS-2019.11>
62. Anlay DZ, Paque K, Van Leeuwen E, Cohen J, Dilles T. Tools and guidelines to assess the appropriateness of medication and aid deprescribing: An umbrella review. *Br J Clin Pharmacol*. 2023;11. doi: 10.1111/bcp.15906.